

Sujet 39 : Hyperthyroïdie

- 1. Une hyperthyroïdie par mutation activatrice du récepteur de la TSH est typique de (obj n°1,5) :**
 - A. Maladie de Basedow
 - B. Adénome toxique
 - C. Thyroïdite de Hashimoto
 - D. Thyroïdite de De Quervain
 - E. Thyroïdite sporadique

- 2. L'hyperthyroïdie induite par l'amiodarone de type II se caractérise par (obj n°1):**
 - A. Goitre homogène, élastique et vasculaire
 - B. Élévation de la thyroglobuline
 - C. Présence d'anticorps antithyroperoxydase
 - D. Thyroïde hypoéchogène à l'échographie
 - E. Absence de fixation de l'iode à la scintigraphie

- 3. Une hyperthyroïdie auto-immune peut être liée à une (obj n°1) :**
 - A. Thyroïdite de De Quervain
 - B. Thyroïdite subaiguë silencieuse
 - C. Maladie de Basedow
 - D. Thyroïdite post-radique
 - E. Thyroïdite lymphocytaire chronique

- 4. L'hyperthyroïdie a comme effet métabolique (obj n°2) :**
 - A. Hyperglycémie par insulino-pénie
 - B. Stimulation de la protéolyse
 - C. Réduction de la consommation d'oxygène
 - D. Stimulation de la lipogénèse
 - E. Diminution de la lipolyse

- 5. L'excès en hormones thyroïdiennes peut entraîner (obj n°2) :**
 - A. Une vasodilatation
 - B. Une HTA diastolique
 - C. Une diminution de la lipogénèse
 - D. Une stimulation de la lipolyse
 - E. Une hyperfiltration glomérulaire

6. *L'hyperthyroïdie prolongée non traitée expose au risque de (obj n°4) :*

- A. Déficit musculaire proximal
- B. Cytolyse modérée
- C. Ostéomalacie
- D. Tassement vertébral
- E. Accès maniaque

7. *Le retentissement cardio-vasculaire de l'hyperthyroïdie comporte (obj n°2,4) :*

- A. Une vasodilatation
- B. Une HTA diastolique
- C. Une augmentation du débit cardiaque
- D. Une insuffisance cardiaque droite
- E. Un flutter auriculaire

8. *On peut trouver dans l'hyperthyroïdie périphérique fruste une (obj n°3) :*

- A. Anémie
- B. TSH normale
- C. Hypercholestérolémie
- D. Hyponatrémie
- E. Hypoglycémie

9. *L'hyperthyroïdie peut se manifester par (obj n°3):*

- A. Une décompensation d'une coronaropathie
- B. Une rhabdomyolyse
- C. Un trouble de la marche
- D. Une rétraction de la paupière supérieure
- E. Une gynécomastie

10. *Une hyperthyroïdie peut être révélée par (obj n°3) :*

- A. Un myxœdème généralisé
- B. Des troubles psychiatriques
- C. Un prurit
- D. Un syndrome polyuro-polydipsique
- E. Une spanioménorrhée

11. *Dans l'hyperthyroïdie, l'accroissement du remodelage osseux se manifeste par (obj n°3) :*

- A. Elévation des phosphatases alcalines
- B. Elévation des transaminases
- C. Baisse de l'ostéocalcine sérique
- D. Hypercalcémie
- E. Elévation de la parathormone

12. Une TSH basse associée à une FT4 normale peut se voir en cas de (obj n°3,5,8):

- A. Hyperthyroïdie centrale
- B. Hyperthyroïdie fruste
- C. Altération de l'état général
- D. Corticothérapie prolongée
- E. Prise d'antithyroïdien de synthèse

13. Une TSH normale ou élevée dans un contexte d'hyperthyroïdie oriente vers (obj n°5) :

- A. Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes
- B. Adénome hypophysaire thyroïdrotrope
- C. Thyroïdite subaiguë
- D. Goitre ovarien toxique
- E. Toxicose factice

14. La thyrotoxicose factice est confirmée par (obj n°5) :

- A. Anticorps anti-RTSH positifs
- B. Hyperfixation scintigraphique
- C. Thyroglobuline effondrée
- D. Élévation des transaminases
- E. Thyroïde de volume normal

15. Le pronostic vital peut être mis en jeu en cas d'hyperthyroïdie devant (obj n°4) :

- A. Ophtalmopathie Basedowienne maligne
- B. Crise aiguë thyrotoxique
- C. Hypothyroïdie induite par l'iode radioactif
- D. Paralysie périodique thyrotoxique hypokaliémique
- E. Cardiothyroïdose

16. L'hyperthyroïdie chez le sujet âgé se distingue par (obj n°6) :

- A. Cachexie
- B. Exophtalmie bilatérale
- C. Tremblements fins des extrémités
- D. Humeur labile
- E. Fonte musculaire sévère

17. La crise thyrotoxique peut être déclenchée par (obj n°4) :

- A. Infection bactérienne
- B. Angio-TDM thoracique
- C. Corticothérapie
- D. Régime désodé
- E. Hydratation abondante

18. Dans la maladie de Basedow, l'ophtalmopathie (obj n°6) :

- A. Est corrélée au taux d'anticorps anti-RTSH
- B. Est corrélée au degré de thyrotoxicose
- C. Est aggravée par le tabac
- D. Régresse en cas de passage en hypothyroïdie
- E. Contre-indique l'iode radioactif

19. Dans la thyrotoxicose gestationnelle transitoire, on observe (obj n°6) :

- A. Positivité des anticorps anti-RTSH
- B. Régression spontanée au deuxième trimestre
- C. Nécessité des antithyroïdiens de synthèse
- D. Exophtalmie associée
- E. Risque élevé d'hypothyroïdie fœtale

20. La thyroïdite du post-partum (obj n°6) :

- A. Nécessite un traitement radical par iode radioactif
- B. Peut évoluer vers une hypothyroïdie transitoire
- C. Se caractérise par une scintigraphie blanche
- D. Est associée à des anticorps anti-RTSH positifs
- E. Contre-indique une nouvelle grossesse

21. Une thyroïdite subaiguë de De Quervain minime peut être traitée par (obj n°7) :

- A. Antithyroïdiens de synthèse
- B. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- C. Propranolol
- D. Iode radioactif
- E. corticoïdes

22. Les antithyroïdiens de synthèse ont comme effets indésirables sévères (obj n°8) :

- A. Rash cutané
- B. Arthralgies
- C. Epigastralgies
- D. Agranulocytose
- E. Hépatite cytolytique

23. On peut préconiser chez la femme enceinte et selon la sévérité de l'hyperthyroïdie (obj n°7) :

- A. Thyroïdectomie totale
- B. Propylthiouracile
- C. Propranolol
- D. Faible dose d'iode radioactif
- E. Méthimazole au premier trimestre

24. L'iode radioactif est relativement contre-indiqué dans (obj n°7) :

- A. Goitre multi-nodulaire toxique chez une femme ménopausée
- B. Récurrence d'une maladie de Basedow
- C. Adénome toxique chez une femme mariée sous contraception
- D. Troisième trimestre de la grossesse
- E. Orbitopathie maligne

25. La surveillance d'un nouveau-né de mère atteinte de maladie de Basedow inclut (obj n°8) :

- A. Dosage de la TSH à l'âge de 1 an
- B. Dépistage d'hyperthyroïdie néonatale
- C. Scintigraphie thyroïdienne
- D. Interdiction de l'allaitement maternel
- E. Cure préventive d'iode radioactif

26. En faveur d'une hyperthyroïdie fœtale à l'échographie (obj n°6) :

- A. Tachycardie fœtale
- B. Myxœdème
- C. Retard de croissance sévère
- D. Anasarque
- E. Avance de maturation osseuse

27. Le propranolol dans l'hyperthyroïdie (obj n°7) :

- A. Stimule la conversion périphérique de T4 en T3
- B. Réduit les tremblements
- C. Est contre-indiqué en cas d'asthme
- D. Réduit les palpitations
- E. Augmente la fixation de l'iode radioactif

28. Le traitement par iode stable (Lugol) permet de (obj n°7) :

- A. Inhiber le transport de l'iode
- B. Inhiber l'organification de l'iode
- C. Inhiber la sécrétion des hormones thyroïdiennes
- D. Prévenir l'ophtalmopathie Basedowienne
- E. Réduire la vascularisation du goitre

Cas clinique 1 :

Une femme de 28 ans, enceinte à 9 SA, présente des vomissements incoercibles et une perte de poids. Elle n'a pas de goitre ni d'exophtalmie. Son bilan montre : kaliémie à 3,2 mmol/l (3,5 – 5 mmol/l), TSH < 0,05 mUI/L, FT4 à 26 (12 – 22 pmol/l), β HCG positive, anticorps anti-RTSH et anti-TPO négatifs.

29. Le diagnostic évoqué chez cette patiente est (obj n°6) :

- A. Maladie de Basedow à début gravidique
- B. Thyrotoxicose gestationnelle transitoire
- C. Thyroïdite silencieuse
- D. Thyroïdite de Hashimoto
- E. Choriocarcinome

30. La prise en charge immédiate repose sur (obj n°7) :

- A. Interruption thérapeutique de grossesse
- B. Antithyroïdiens de synthèse à forte dose
- C. Correction des troubles hydroélectrolytiques
- D. Hospitalisation en gynécologie
- E. Traitement symptomatique des vomissements

31. L'évolution dans ce cas se caractérise par (obj n°6) :

- A. Régression spontanée à la 2ème partie de la grossesse
- B. Apparition de l'ophtalmopathie dans un tiers des cas
- C. Anomalies du scalp associées aux antithyroïdiens de synthèse
- D. Hypothyroïdie congénitale chez le nouveau-né
- E. Malformations cardiaques chez le fœtus

Cas clinique 2 :

Un patient de 72 ans sous amiodarone pour fibrillation auriculaire présente une altération de l'état général avec fièvre à 38,5°C, œdème des membres inférieures et agitation. Son bilan montre une TSH < 0,01 mUI/L et une FT4 très élevée. La scintigraphie thyroïdienne est blanche.

32. Le mécanisme de l'hyperthyroïdie dans ce cas est (obj n°1) :

- A. Surcharge iodée de type I
- B. Surcharge iodée de type II
- C. Thyroïdite de hashimoto
- D. Maladie de Basedow
- E. Thyrotoxicose factice

33. La prise en charge initiale urgente comporte (obj n°7) :

- A. Antithyroïdiens de synthèse
- B. Corticothérapie systémique
- C. Iode radioactif
- D. Lithium
- E. Thyroïdectomie

34. Il faut redouter dans ce cas (obj n°4) :

- A. Myxœdème
- B. Hypocalcémie
- C. Paralysie récurrentielle
- D. Insuffisance cardiaque
- E. Crise aiguë thyrotoxique

Cas clinique 3 :

Une patiente âgée de 40 ans, consulte pour fièvre à 39,5°C. Elle est suivie pour une hyperthyroïdie depuis 5 mois découverte devant des diarrhées chroniques à 2 fois par jour et des palpitations. Elle a reçu initialement un traitement par propranolol et thiamazole qu'elle les a arrêtées depuis 2 mois.

A la suite du décès de sa mère il y a une semaine, elle rapporte des diarrhées à raison de 5 fois par jour, des tremblements des extrémités et des palpitations.

A l'examen, pas d'exophtalmie, présence d'un goitre diffus, homogène, vasculaire et non douloureux, absence de myxœdème pré-tibial. A la biologie, TSH freinée et FT4 > 100 (12-22 pmol/l), glycémie à jeun 1,12 g/l, CRP négative. A l'ECG : tachycardie sinusale à 130bpm. Vous suspectez une crise aiguë thyrotoxique.

35. La crise aiguë thyrotoxique est suspectée devant (obj n°) :

- A. Les diarrhées chroniques
- B. La fièvre
- C. La cardiomyopathie
- D. L'absence du traitement
- E. Le stress intense

36. La Maladie de Basedow est l'étiologie à évoquer dans ce cas devant (obj n°) :

- A. L'âge de la patiente
- B. Le sexe féminin
- C. La crise aiguë thyrotoxique
- D. Les caractéristiques du goitre
- E. L'élévation franche de la FT4

37. La conduite thérapeutique de la crise aiguë thyrotoxique comporte (obj n°) :

- A. Hospitalisation en unités de soins intensifs
- B. Thyroxine par voie intraveineuse
- C. Beta bloquant par voie intraveineuse
- D. Corticoïdes par voie inhalées
- E. Lutte contre la fièvre

38. Le traitement de l'hyperthyroïdie chez cette patiente après la prise en charge de la crise aiguë thyrotoxique doit inclure (obj n°) :

- A. Le thiamazole à vie
- B. La metformine
- C. L'iode minérale
- D. Une cure d'iode radioactif
- E. Une thyroïdectomie subtotale